

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA SUBOCLUSIÓN INTESTINAL ADHESIVA

Unidad de Observación de Media Estancia (UOME)

1. OBJETIVO

Manejo protocolizado de pacientes con suboclusión intestinal adhesiva valorados por Cirugía General y candidatos a tratamiento conservador en UOME, con estancia máxima prevista de 36 horas.

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN UOME SIN TC ABDOMINAL PREVIA

Podrá considerarse el ingreso sin TC previa cuando se cumplan **todos** los siguientes criterios:

- Diagnóstico clínico compatible con suboclusión intestinal adhesiva recurrente.
- Antecedente **documentado** de obstrucción/suboclusión por bridas o adherencias.
- Valoración por Cirugía General con indicación de tratamiento conservador.
- Estabilidad clínica y analítica.
- Abdomen sin signos de irritación peritoneal ni sospecha de isquemia, perforación o estrangulación intestinal.
- Previsión de resolución con tratamiento conservador en ≤ 36 horas.

Si existe sospecha clínica de etiología adhesiva, pero no está previamente documentada → realizar TC abdominal antes del ingreso en UOME.

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE UOME

- Inestabilidad hemodinámica o sepsis.
- Dolor continuo o no controlable.
- Signos de irritación peritoneal.
- Sospecha de isquemia, perforación o estrangulación intestinal.
- Alteraciones analíticas de alarma, especialmente hiperlactatemia.
- Necesidad de cirugía urgente.

4. VALORACIÓN INICIAL

Realizada en Urgencias y revisada por Cirugía General.

Analítica

Hemograma · Bioquímica · Coagulación · Gasometría venosa con lactato.

Pruebas de imagen

- Serie obstructiva.
- TC abdominal compatible con suboclusión intestinal adhesiva, sin signos de complicación.

5. TRATAMIENTO

Medidas generales

- Dieta absoluta.
- Fluidoterapia IV ajustada a necesidades, pérdidas digestivas y comorbilidades.
- Corrección de alteraciones hidroelectrolíticas cuando proceda.

Analgesia

- Paracetamol 1 g IV cada 8 horas.
- Metamizol 2 g IV cada 8 horas si precisa.
- Butilescopolamina (Buscapina®) 20 mg IV cada 8 horas si dolor tipo cólico.
- Dolantina® (Meperidina) 50–100 mg IV lenta si precisa.
- Fentanilo IV titulado o Tramadol 100 mg IV según criterio médico.

Antieméticos

- Metoclopramida 10 mg IV cada 8 horas si precisa.
- Ondansetrón 4 mg IV cada 8 horas si precisa.

6. SONDA NASOGÁSTRICA

No indicada de forma rutinaria.

Indicaciones

- Náuseas o vómitos persistentes.
- Distensión abdominal importante.
- Dilatación gástrica significativa en la TC.
- Mala evolución clínica durante la observación.

Objetivo

Descompresión digestiva, control de náuseas/vómitos y reducción del riesgo de broncoaspiración.

Controles clínicos

- **Débito:** cuantificar cada 8 horas. Si >1.000–1.500 ml/24 h, valorar reposición de pérdidas y control hidroelectrolítico. Si <300–500 ml/24 h + recuperación del tránsito, orienta a evolución favorable.
- **Aspecto:** registrar contenido gástrico/bilioso. Contenido porráceo o fecaloideo → reevaluación médica.
- **Permeabilidad:** comprobar fijación y funcionamiento cada turno; caída libre/aspiración suave según indicación. Lavado con SF si sospecha de obstrucción.
- **Alarma clínica:** dolor continuo, distensión progresiva o vómitos pese a SNG → reevaluación médica y por Cirugía General.

Retirada

Tras valoración por Cirugía General, cuando exista mejoría clínica, desaparición de náuseas/vómitos, disminución o ausencia de débito y recuperación del tránsito intestinal.

7. SONDA RECTAL

No indicada de forma rutinaria. Podrá valorarse por Cirugía General en casos seleccionados con distensión importante o necesidad de descompresión distal.

8. CONTROL EVOLUTIVO Y VENTANA DE SEGURIDAD

Constantes

Cada 4 horas durante la estancia en UOME.

Reevaluación médica a las 6–8 horas

- Dolor y distensión abdominal.
- Náuseas/vómitos y necesidad o funcionamiento de SNG.
- Recuperación del tránsito intestinal (gases y/o deposición).
- Exploración abdominal y valoración evolutiva conjunta con Cirugía General.

REEVALUACIÓN / RESCATE RADIOLÓGICO A LAS 12–24 HORAS

- **Sin mejoría clínica evidente:** ausencia de expulsión de gases/heces, sin disminución significativa del débito de SNG o persistencia de distensión → TC abdominal con contraste IV de forma preferente.
- **Viraje clínico de alarma:** cualquier signo sistémico o abdominal de alarma → TC abdominal urgente + interconsulta inmediata a Cirugía General.
- **Evolución favorable:** valorar progresión de dieta, retirada de SNG cuando proceda y decisión de alta.

9. CONTROLES DE ENFERMERÍA

- Constantes cada 4 horas.
- Dolor mediante escala numérica 0–10.
- Balance hídrico: Registro de fluidoterapia, diuresis y pérdidas digestivas.
- Administración del tratamiento pautado.
- Comunicación al facultativo ante cambios clínicos o signos de alarma.

10. CRITERIOS DE ALTA

- Mejoría del dolor y de la distensión abdominal.
- Ausencia de náuseas o vómitos.
- Recuperación del tránsito intestinal (gases y/o deposición), con adecuada tolerancia oral y progresión de la dieta.
- Ausencia de signos de alarma.
- Valoración favorable por Cirugía General.

Recomendaciones al alta

- Dieta progresiva según tolerancia y adecuada hidratación.
- Reconsulta por dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, fiebre o ausencia de tránsito intestinal.
- Seguimiento según indicación de Cirugía General.

11. CRITERIOS DE INGRESO

- Persistencia de la suboclusión tras tratamiento conservador.
- Empeoramiento clínico o aparición de irritación peritoneal.
- Deterioro analítico o radiológico.
- Necesidad de tratamiento quirúrgico.

12. BIBLIOGRAFÍA

Di Saverio S, Catena F, Ansaloni L, et al. Bologna Guidelines for Diagnosis and Management of Adhesive Small Bowel Obstruction (ASBO): 2017 Update of the WSES. World Journal of Emergency Surgery. 2018.

Asociación Española de Cirujanos (AEC). Manual de Cirugía de Urgencias.

UpToDate. Management of Adhesive Small Bowel Obstruction in Adults.

World Society of Emergency Surgery (WSES). Clinical Guidelines for Adhesive Small Bowel Obstruction.

Protocolos de Cirugía General. Adaptación local según Hospital Universitario San Agustín / HUCA.